急性缺血性脑卒中急诊急救中国专家共识

急性脑卒中是一种发病率高、致残率高、病死率高、复发率高及并发症多的疾病[1-2]。据统计，2013年中国卒中的年龄标化患病率为1114.8/10万人，发病率为246.8/10万人，死亡率为114.8/10万人[3]。目前，急性缺血性卒中（acuteischemicstroke,AIS）最有效的治疗方法是时间窗内给予血管再通治疗，包括重组组织型纤溶酶原激活剂（recombinanttissueplasminogenactivator,rt-PA）静脉溶栓和机械取栓，救治成功率与发病时间密切相关[4-5]。由于我国群众对该疾病早期识别认知度低、院前救治能力不足、院内急诊延误等导致AIS救治延迟以及溶栓率较低[6]，我国在发病3h内到达急诊科的AIS患者只有21.5%，适合溶栓治疗者仅12.6%，而进行了溶栓治疗的患者只有2.4%；从患者进入急诊科到接受溶栓药物治疗的平均间隔时间为116min，比发达国家显著延长[7-8]。因此，我国缺血性卒中患者救治效率仍不理想，形势严峻。AIS救治可以分为三个阶段：院前、急诊、住院治疗。2013年美国心脏病协会/美国卒中协会(AHA/ASA)《急性缺血性卒中患者的早期管理指南》中将卒中急救流程概括为8D生存链：detection(发现)，dispatch(派遣)，delivery(转运)，door(到院)，data(检查资料)，decision(临床决策)，drug(药物治疗)，disposition(安置)[8]。首都医科大学附属北京天坛医院结合我国基本国情[9]提出脑卒中治疗教育工程的概念，强调应该将院前、急诊、住院治疗有机地联系起来。本共识着重于前两个部分的内容，以期优化我国AIS急诊急救的流程、促进救治效率、改善患者预后、降低致残率和死亡率。